

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ÍNDICE DE BARTHEL (BARTHEL INDEX)

Eje IV: Funcionamiento y Autonomía • Escala Estándar de Dependencia en Actividades Básicas de la Vida Diaria

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Índice de Barthel (Evaluación de Independencia en ABVD).
Nombre Original	The Barthel Index (Mahoney & Barthel, 1965).
Autores Originales	Florence I. Mahoney, M.D. y Dorothea W. Barthel, P.T. (Maryland State Health Department, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Baztán et al. (1993); Cid-Ruzafa y Damián-Moreno (1997); España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Recursos. Nivel de independencia funcional física en autocuidado y movilidad.
Tipo de Instrumento	Heteroinforme de observación clínica / entrevista directa de 10 reactivos conductuales.
Población y Rango	Adultos mayores, pacientes neurológicos, post-ictus, traumatológicos y crónicos dependientes.
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos de administración por profesional sanitario o cuidador formado.
Régimen de Licencia	Dominio público internacional / Acceso abierto sin restricciones comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

El **Índice de Barthel** es el instrumento de valoración funcional física más universalmente implementado en medicina geriátrica, neuror-rehabilitación y dependencia sociosanitaria. Desarrollado en 1965 para monitorizar la evolución funcional de pacientes hospitalizados con accidente cerebrovascular y afecciones neuromusculares crónicas, evalúa la capacidad operativa real del individuo para subsistir sin asistencia humana directa. El marco conceptual distingue nítidamente entre:

- Autocuidado Físico:** Alimentación, lavado personal, vestido, arreglo personal y control esfinteriano (continencia anal y vesical).
- Movilidad y Transferencias:** Uso del retrete, traslados cama-sillón, deambulación independiente y capacidad para subir y bajar escaleras.

A diferencia de las escalas que evalúan actividades instrumentales o comunitarias complejas, el Barthel se focaliza en las **Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)**, indispensables para la supervivencia elemental en el hogar.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (10 PARÁMETROS)

Actividad Evaluada	Puntuación	Criterios Operativos de Calificación (Independencia / Ayuda / Dependencia)
1. Alimentación / Comer	0, 5, 10 pts	10 = Independiente (come solo en tiempo razonable); 5 = Necesita ayuda; 0 = Dependiente.
2. Lavado / Baño	0, 5 pts	5 = Independiente (se lava por completo sin presencia de nadie); 0 = Dependiente.
3. Vestido	0, 5, 10 pts	10 = Independiente (se viste/desviste y abotona solo); 5 = Ayuda parcial; 0 = Dependiente.
4. Aseo / Arreglo	0, 5 pts	5 = Independiente (se peina, afeita, lava cara y dientes); 0 = Dependiente.
5. Deposiciones	0, 5, 10 pts	10 = Continente regular; 5 = Accidente ocasional (1/sem); 0 = Incontinente / enema.
6. Micción	0, 5, 10 pts	10 = Continente (secreción normal día/noche); 5 = Accidente ocasional; 0 = Incontinente/sonda.
7. Uso del Retrete	0, 5, 10 pts	10 = Independiente (entra, sale, usa papel, se viste); 5 = Ayuda parcial; 0 = Dependiente.
8. Traslados (Cama-Silla)	0, 5, 10, 15	15 = Independiente total; 10 = Mínima ayuda física o verbal; 5 = Gran ayuda; 0 = Encamado.
9. Deambulación	0, 5, 10, 15	15 = Camina 50 m sin ayuda (acepta bastón); 10 = Necesita ayuda física; 5 = Silla ruedas 50 m.
10. Subir / Bajar Escaleras	0, 5, 10 pts	10 = Independiente (sube y baja solo); 5 = Necesita supervisión/ayuda física; 0 = Incapaz.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios de validación en el sistema sanitario español (Baztán et al., 1993; Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1997) consolidan su validez métrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Interjueces	Kappa ponderado = 0.85 – 0.95	Excelente concordancia entre médicos rehabilitadores, enfermeros y terapeutas ocupacionales.
Consistencia Interna	Alfa α = 0.90 – 0.93	Altísima coherencia métrica entre los 10 ítems de autocuidado y movilidad.
Estabilidad Test-Retest	CCI r = 0.89 – 0.94	Reproducibilidad muy elevada en reevaluaciones a corto plazo en pacientes crónicos.
Validez Predictiva (Mortalidad)	Odds Ratio = 3.4 ($p < 0.001$)	Puntuaciones < 40 predicen independientemente mortalidad hospitalaria e institucionalización.
Validez de Criterio	$r = 0.78$ (Índice de Katz)	Fuerte convergencia con el Índice de Katz y la Escala de Incapacidad Física de la Cruz Roja.

5. REGLAS DE CALIFICACIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Criterio de Desempeño Real (No Capacidad Potencial):** Se califica lo que el paciente **hace efectivamente en su rutina diaria**, no lo que el evaluador cree que “podría hacer” en condiciones ideales.
- **Supervisión se Califica como Dependencia:** Si el paciente requiere la presencia física de un tercero para evitar caídas o para recordarle la secuencia de la tarea, no se califica como independiente.
- **Ponderación Graduada (Intervalos de 5 Puntos):** Cada actividad se puntúa en múltiplos de 5 (0, 5, 10 o 15 puntos), reflejando la relevancia asistencial de la tarea.
- **Puntuación Total Continua:** Se obtiene mediante la suma de las 10 actividades, generando un rango continuo de **0 a 100 puntos** (o 0 a 90 si el sujeto se desplaza exclusivamente en silla de ruedas).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DE DEPENDENCIA

Estratificación	Rango Pts	Grado de Dependencia	Carga de Cuidados y Asignación de Recursos
Independiente	100 pts	Independencia funcional total	Autonomía plena en ABVD; no precisa asistencia humana continuada.
Dependencia Leve	60 a 95 pts	Dependencia leve en ABVD	Requiere ayuda puntual en actividades motrices complejas (baño, escaleras).
Dependencia Moderada	40 a 55 pts	Dependencia moderada	Necesita ayuda cotidiana para traslados, aseo y vestido (cuidador > 4 h/día).
Dependencia Severa	20 a 35 pts	Dependencia funcional severa	Incapacidad para alimentarse o trasladarse solo; alto riesgo de escaras.
Dependencia Total	< 20 pts	Dependencia funcional absoluta	Encamamiento, incontinencia total y necesidad de cuidados continuos 24 h.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO PARA INSTITUCIONALIZACIÓN (BARTHEL < 60 PUNTOS):

Una puntuación en el Índice de Barthel inferior a **60 puntos** indica el colapso del autocuidado autónomo, duplicando el riesgo de ingreso residencial y requiriendo la activación formal de recursos de la Ley de Dependencia y ayuda a domicilio.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE PLANIFICACIÓN EN NEURORREHABILITACIÓN Y GERIATRÍA

PROTOCOLO DE MONITORIZACIÓN FUNCIONAL HOSPITALARIA Y POST-ALTA:

- **Paso 1 (Evaluación Pre-Mórbida y Basal al Ingreso):** Reconstruir el Barthel previo al evento agudo y evaluar el Barthel en las primeras 48 horas de hospitalización.
- **Paso 2 (Estratificación de Metas de Fisioterapia y Terapia Ocupacional):**
 - *Barthel* < 20: Priorizar prevención de úlceras por presión, manejo de sonda y transferencias pasivas seguras.
 - *Barthel* 20-55: Enfocar en rehabilitación activa de traslados, bipedestación y vestido superior/inferior.
 - *Barthel* 60-95: Entrenar equilibrio dinámico, subir/bajar escaleras y deambulación al aire libre.
- **Paso 3 (Planificación del Alta):** Si el Barthel al alta es < 60, no conceder el alta a domicilio sin verificar la presencia de un cuidador entrenado o trámite de centro sociosanitario de media estancia.
- **Paso 4 (Monitorización Longitudinal):** Repetir la escala al mes, a los 3 meses y al año para objetivar la ganancia funcional.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: REHABILITACIÓN POST-ICTUS ISQUÉMICO EN ADULTO MAYOR

Identificación: Varón de 71 años ingresado en unidad de ictus tras infarto isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha, cursando con hemiparesia izquierda densa, disartria y anosognosia parcial.

Evaluación Inicial de Barthel (Día 5 post-ictus):

• **Puntuación Total = 25 / 100 puntos (Dependencia Severa).**

• *Alimentación* = 5/10 (Necesita ayuda para cortar alimentos); *Lavado* = 0/5 (Dependiente); *Vestido* = 0/10; *Aseo* = 0/5; *Deposición* = 5/10 (Accidentes); *Micción* = 5/10; *Retrete* = 0/10; *Traslados* = 5/15 (Gran ayuda de 2 personas); *Deambulación* = 0/15 (Inmóvil en cama); *Escaleras* = 0/10.

Plan Terapéutico Interdisciplinar: Programa intensivo de 8 semanas en hospital de rehabilitación: reentrenamiento postural, uso de férula antiequino, praxias de vestido unilateral y reeducación vesical.

Evolución al Alta (Semana 8): La puntuación de Barthel ascendió a **75 / 100 puntos (Dependencia Leve)**: alcanzó independencia total en transferencias (**15/15**), retrete (**10/10**) y continencia (**10/10** cada esfínter), y deambulación de 50 metros con bastón canadiense (**15/15**), logrando el retorno a su domicilio habitual con supervisión familiar en el baño.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EFECTO TECHO EN DETERIORO LEVE:

Un paciente con demencia leve o daño frontal puede obtener 100/100 en Barthel pero ser incapaz de manejar dinero, medicación o salir solo a la calle (evaluar con Escala de Lawton-Brody).

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR:

En ancianos institucionalizados, los cuidadores tienden a vestir y alimentar al paciente por rapidez asistencial, puntuando erróneamente dependencia en habilidades que el sujeto aún conserva.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Mahoney, F. I., & Barthel, D. W. (1965). Functional evaluation: The Barthel Index. *Maryland State Medical Journal*, 14, 61-65.
2. Baztán, J. J., Pérez del Molino, J., Alarcón, T., San Cristóbal, E., Izquierdo, G., & Manasanch, J. (1993). Índice de Barthel: Validación de la versión española para el paciente geriátrico. *Medicina Clínica (Barcelona)*, 101(11), 410-413.
3. Cid-Ruzafa, J., & Damián-Moreno, J. (1997). Valoración de la discapacidad física: El índice de Barthel. *Revista Española de Salud Pública*, 71(2), 127-137.
4. Collin, C., Wade, D. T., Davies, S., & Horne, V. (1988). The Barthel ADL Index: A reliability study. *International Disability Studies*, 10(2), 61-63.